

ISAS

Inventory of Statements About Self-Injury

Inventario de afirmaciones sobre autolesión

FICHA TÉCNICA

Versión española examinada: Pérez, García-Alandete, Cañabate y Marco

1. Identificación del instrumento

Aspecto	Descripción
Nombre original	Inventory of Statements About Self-Injury.
Sigla	ISAS.
Denominación en español	Inventario de afirmaciones sobre autolesión / Inventario de declaraciones sobre autolesión. La denominación varía entre adaptaciones.
Autores	E. David Klonsky y Catherine R. Glenn.
Año de publicación	2009. El artículo fue publicado en Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, volumen 31, páginas 215–219.
Constructo principal	Conductas de autolesión no suicida (ANS/NSSI) y funciones atribuidas a dichas conductas.
Tipo de instrumento	Autoinforme estructurado, compuesto por una sección conductual y una sección funcional.
Población de interés	Adolescentes, adultos jóvenes y adultos con antecedentes de al menos una conducta de autolesión no suicida. Existen estudios en muestras comunitarias y clínicas.
Ámbitos de uso	Investigación, evaluación clínica, formulación funcional y seguimiento. No es una prueba diagnóstica ni una escala autónoma de riesgo suicida.
Tiempo orientativo	Aproximadamente 10–15 minutos; puede variar según la historia de autolesión y las aclaraciones requeridas.
Modalidad	Aplicación individual o colectiva; formato papel o digital, con condiciones de privacidad.
Versión española examinada	Traducción y validación en muestra clínica española comunicada por Pérez, García-Alandete, Cañabate y Marco (2020). El formulario aportado cita esa validación.

Precisión terminológica. La ISAS evalúa autolesión intencional sin intención de morir. La ausencia de intención suicida debe explorarse clínicamente; no debe inferirse únicamente porque la persona complete el instrumento.

2. Propósito y fundamento conceptual

La ISAS fue desarrollada para describir de manera integrada qué formas de autolesión no suicida ha realizado una persona y qué funciones subjetivas atribuye a esas conductas. Su lógica es funcional: una misma conducta puede mantenerse por razones diferentes, y una misma persona puede respaldar varias funciones simultáneamente.

La sección funcional reúne 13 motivos documentados en la literatura. En el estudio original, estas funciones se organizaron en dos dominios superiores correlacionados: funciones intrapersonales, centradas en modificar estados internos, y funciones interpersonales, relacionadas con efectos sociales, comunicativos, identitarios o relacionales.

Usos apropiados

- Caracterizar la frecuencia y variedad de conductas de autolesión no suicida.
- Identificar funciones predominantes para orientar la formulación clínica.
- Generar hipótesis sobre antecedentes, consecuencias y reforzadores de la conducta.
- Comparar perfiles funcionales en investigación.
- Complementar el seguimiento clínico, sin convertir cambios de puntuación en el único indicador de evolución.

Usos no apropiados

- Establecer por sí sola un diagnóstico clínico.
- Descartar o confirmar riesgo suicida.
- Clasificar mecánicamente a una persona como de riesgo bajo, medio o alto.
- Interpretar una función elevada como causa demostrada de la autolesión.
- Aplicar sin un procedimiento de respuesta ante malestar agudo o revelación de riesgo.

3. Estructura general

Componente	Contenido	Resultado principal
Sección I: conductas	Registra la frecuencia de formas específicas de autolesión a lo largo de la vida y variables descriptivas asociadas.	Perfil conductual; no produce una puntuación única estandarizada.
Sección II: funciones	39 afirmaciones, tres por cada una de 13 funciones. Solo se responde cuando existe al menos una conducta de autolesión informada.	13 puntuaciones funcionales de 0 a 6 y, cuando se justifica, dos dominios superiores.

3.1. Sección I: conductas de autolesión

Conducta	Descripción operativa
Cortarse	Producir cortes intencionales en la piel.
Rascarse intensamente	Rascar la piel con fuerza hasta producir lesión o sangrado.
Morderse	Morder el propio cuerpo de forma deliberada y lesiva.
Golpearse	Golpearse deliberadamente o golpear partes del cuerpo contra objetos.
Quemarse	Provocar quemaduras de manera intencional.
Interferir en la curación	Manipular heridas o costras para impedir o retrasar la cicatrización.
Tallarse la piel	Grabar dibujos, palabras o símbolos en la piel.
Frotar la piel	Frotar la piel contra una superficie rugosa para producir daño.
Pellizcarse	Pellizcar la piel de forma intensa y deliberada.
Pincharse	Puncionar la piel con agujas u otros objetos.
Tirarse del pelo	Arrancarse el cabello de forma intencional dentro del marco de autolesión indicado.
Ingerir sustancias peligrosas	Consumir deliberadamente sustancias dañinas sin intención de morir.
Otros	Permite registrar conductas no incluidas en las categorías anteriores.

Además de la frecuencia vital aproximada, la sección pregunta por la forma principal o más frecuente, edad de inicio, episodio más reciente, experiencia de dolor físico, realización en soledad, intervalo entre el impulso y la conducta, y deseo de abandonar la autolesión.

Lectura clínica. La frecuencia vital suele ser difícil de estimar cuando las conductas son repetitivas. Conviene registrar el valor informado como estimación y complementarlo con periodo reciente, frecuencia típica, gravedad médica, contexto e intención.

4. Sección II: dimensiones, ítems y contenido

Función	Ítems	Contenido evaluado	Dominio superior original
Regulación afectiva	1, 14, 27	Reducir tensión, ansiedad, ira u otros estados emocionales intensos.	Intrapersonal
Límites interpersonales	2, 15, 28	Crear separación, frontera o distancia respecto de otras personas.	Interpersonal
Autocastigo	3, 16, 29	Castigarse o expresar ira y desaprobación hacia uno mismo.	Intrapersonal
Autocuidado	4, 17, 30	Convertir el malestar emocional en una lesión física que puede cuidarse o tratarse.	Interpersonal en el modelo original*
Antidisolución / antidisociación	5, 18, 31	Interrumpir embotamiento, irrealidad o ausencia de sensaciones; volver a sentirse vivo.	Intrapersonal
Antisuicidio	6, 19, 32	Evitar o frenar pensamientos e impulsos suicidas sin intentar morir.	Intrapersonal
Búsqueda de sensaciones	7, 20, 33	Obtener excitación, intensidad o una experiencia extrema.	Interpersonal en el modelo original
Vinculación con pares	8, 21, 34	Sentirse unido, integrado o identificado con otras personas que se autolesionan.	Interpersonal
Influencia interpersonal	9, 22, 35	Comunicar dolor, obtener ayuda o evitar abandono.	Interpersonal
Fortaleza	10, 23, 36	Probar capacidad de soportar dolor o demostrar dureza.	Interpersonal
Marcar el malestar	11, 24, 37	Hacer visible, concreto o real el sufrimiento emocional.	Intrapersonal
Venganza	12, 25, 38	Herir emocionalmente, castigar o vengarse de otras personas.	Interpersonal
Autonomía	13, 26, 39	Demostrar autosuficiencia, independencia o no necesidad de ayuda.	Interpersonal

* En la validación clínica española, el modelo de dos factores fue respaldado, pero la función de autocuidado se ubicó en el dominio intrapersonal. Esta diferencia debe considerarse al comparar resultados entre versiones y estudios.

4.1. Ítems invertidos

La ISAS-II no contiene ítems invertidos. Todos los reactivos se puntúan en la misma dirección: una respuesta mayor indica mayor relevancia atribuida a la función correspondiente.

5. Administración

5.1. Condiciones recomendadas

- Garantizar privacidad suficiente y explicar los límites de la confidencialidad.
- Informar que las preguntas se refieren únicamente a conductas intencionales realizadas sin intención de morir.
- Evitar administrar la escala como un trámite aislado cuando existe malestar intenso, lesiones recientes o sospecha de riesgo.
- Disponer de un profesional o protocolo para aclarar respuestas y actuar ante revelaciones clínicas relevantes.
- En menores de edad, ajustar consentimiento, asentimiento y comunicación con responsables a la normativa y al contexto institucional.

5.2. Secuencia de aplicación

Paso	Acción	Criterio
1	Presentar el propósito	Explicar que se busca comprender conductas y funciones, no juzgar ni sancionar.
2	Completar la Sección I	Registrar únicamente conductas deliberadas y sin intención suicida.
3	Aplicar regla de salto	Si no se informa ninguna conducta, no se completa la Sección II.
4	Completar la Sección II	Valorar cada afirmación de 0 a 2 según su relevancia personal.
5	Revisar omisiones	Aclarar respuestas faltantes sin sugerir una respuesta.
6	Realizar entrevista complementaria	Explorar temporalidad, función, gravedad, intención, riesgo y contexto.

6. Sistema de respuesta y corrección

6.1. Sección I

La frecuencia de cada conducta se registra como número estimado de episodios a lo largo de la vida. Las preguntas restantes se interpretan descriptivamente. No existe una fórmula oficial para combinar todas las respuestas de la Sección I en una puntuación total.

Variable	Forma de registro	Interpretación
Frecuencia por conducta	Número estimado de episodios en la vida.	Intensidad histórica aproximada de cada método.
Diversidad de métodos	Número de categorías con frecuencia mayor que cero.	Amplitud del repertorio conductual; no equivale por sí sola a gravedad.
Conducta principal	Categoría seleccionada.	Método predominante según autoinforme.
Edad de inicio	Edad en años.	Dato evolutivo y temporal.
Último episodio	Fecha aproximada.	Recencia de la conducta.
Dolor / soledad / latencia / deseo de dejar	Categorías de respuesta.	Información contextual para la formulación y la entrevista.

6.2. Sección II

Respuesta	Puntuación
No es relevante en absoluto	0
Es algo relevante	1
Es muy importante / muy relevante	2

Cada función se calcula sumando sus tres ítems. El rango de cada subescala es de 0 a 6. No se invierte ninguna respuesta.

Fórmula. Puntuación de una función = suma de sus tres reactivos. Ejemplo: regulación afectiva = ítem 1 + ítem 14 + ítem 27.

6.3. Dominios superiores

En investigación puede calcularse una puntuación intrapersonal y otra interpersonal sumando o promediando las funciones que integran cada dominio. Debe indicarse explícitamente qué modelo factorial se utilizó. Para la versión clínica española conviene seguir la asignación respaldada por su estudio de validación, en el cual autocuidado se integra en el dominio intrapersonal.

6.4. Puntuación total

No se recomienda interpretar una suma global de los 39 ítems como si representara una intensidad unidimensional de autolesión. El instrumento fue diseñado para obtener perfiles de funciones. Una suma total puede ocultar configuraciones muy diferentes y carece de puntos de corte clínicos universales.

6.5. Respuestas omitidas

Los autores no establecen un procedimiento universal de imputación. En evaluación individual se recomienda aclarar la omisión. En investigación, el tratamiento de datos faltantes debe definirse previamente y comunicarse. No es aconsejable calcular una función cuando falta uno de sus tres reactivos sin justificar el método utilizado.

7. Interpretación

La interpretación debe centrarse en el patrón, no en una etiqueta. Una puntuación alta indica que la persona reconoce esa función como relevante para su autolesión; no demuestra causalidad ni excluye otras funciones.

7.1. Interpretación por función

Rango orientativo	Lectura descriptiva
0	La función no fue reconocida como relevante en los tres reactivos.
1–2	Relevancia baja o circunscrita; conviene explorar ejemplos y circunstancias.
3–4	Función claramente respaldada; puede constituir un mecanismo importante dentro del patrón.
5–6	Función fuertemente respaldada; requiere exploración clínica detallada.

Estos rangos son descriptores prácticos, no puntos de corte diagnósticos ni categorías normativas publicadas por los autores.

7.2. Principios de interpretación clínica

- Comparar las 13 funciones dentro del perfil de la misma persona.
- Explorar las funciones más altas mediante ejemplos conductuales concretos.
- Distinguir la función declarada de los antecedentes y consecuencias observables.
- Considerar que una conducta puede cumplir varias funciones en episodios distintos.
- No interpretar influencia interpersonal como manipulación; puede representar una estrategia desesperada de comunicación o búsqueda de ayuda.
- La función antisuicidio no implica ausencia de riesgo. Puede coexistir con ideación, planes o intentos suicidas.
- Integrar frecuencia, recencia, gravedad médica, impulsividad, acceso a medios, desesperanza, apoyo y contexto.

7.3. Ejemplo de perfil

Un perfil con regulación afectiva = 6, autocastigo = 5, antisociación = 4 e influencia interpersonal = 1 sugiere que la autolesión es descrita principalmente como estrategia intrapersonal para modificar estados emocionales y cognitivos. Esta lectura orienta la entrevista hacia desencadenantes, secuencia emocional, alivio posterior, autocrítica y alternativas de regulación; no autoriza a asumir que esas son las únicas funciones ni que el patrón sea estable.

8. Evidencia psicométrica

8.1. Estudio original

Klonsky y Glenn evaluaron la ISAS en 235 adultos jóvenes universitarios con al menos una conducta de autolesión no suicida. El estudio aportó evidencia de consistencia interna y validez de constructo para las escalas funcionales, y respaldó una estructura de dos factores superiores —intrapersonal e interpersonal— que explicó aproximadamente 61% de la varianza.

Evidencia	Resultado principal
Estructura interna	Las 13 funciones se organizaron en dos dominios superiores correlacionados: intrapersonal e interpersonal.
Consistencia interna	Se informó consistencia adecuada para los dominios superiores; una publicación posterior resume $\alpha \approx .80$ para intrapersonal y $\alpha \approx .88$ para interpersonal.
Validez convergente/constructo	Las puntuaciones funcionales se asociaron de forma coherente con indicadores clínicos y características de autolesión examinadas por los autores.
Muestra	235 jóvenes adultos universitarios con historia de autolesión; esto limita la generalización directa a otras edades y contextos clínicos.

8.2. Estabilidad temporal

Glenn y Klonsky (2011) examinaron la estabilidad a un año. Las correlaciones test–retest de las conductas oscilaron entre .52 y .83, con mediana de .68. Para los dominios superiores fueron .60 en funciones intrapersonales y .82 en funciones interpersonales. En las funciones individuales variaron entre .35 y .89, con mediana de .59.

8.3. Validación clínica española

Pérez et al. (2020) estudiaron 355 participantes españoles con trastornos de la conducta alimentaria o trastorno límite de la personalidad. El análisis factorial confirmatorio respaldó el modelo de dos factores. La función autocuidado cargó en el factor intrapersonal, a diferencia de su ubicación en el modelo original. Se informaron coeficientes de consistencia interna de aproximadamente $\alpha = .89$ para intrapersonal y $\alpha = .87$ para interpersonal, además de evidencia de estabilidad temporal.

Aspecto	Hallazgo
Muestra	355 pacientes; edad media 27.89 años; 315 mujeres y 40 hombres.
Estructura	Confirmación de un modelo de dos factores superiores.
Particularidad	Autocuidado se integró en el dominio intrapersonal.
Consistencia interna	Aproximadamente $\alpha = .89$ intrapersonal y $\alpha = .87$ interpersonal.
Conclusión	Mostró evidencia de validez para evaluar autolesiones no suicida en población clínica española.

8.4. Adaptación en estudiantes mexicanos

Castro Silva et al. (2016) evaluaron una adaptación en 435 universitarios mexicanos con historia de autolesión. Informaron $\alpha = .89$ para la escala y coeficientes entre .72 y .82 para siete factores interpretables. La estructura obtenida no reprodujo exactamente las 13 funciones originales, lo que muestra que las soluciones factoriales pueden variar según adaptación y población.

Conclusión psicométrica. La evidencia general respalda la utilidad de la ISAS para evaluar funciones de autolesión, pero la configuración de algunas funciones —especialmente autocuidado— puede variar entre muestras. En investigación debe verificarse la estructura en la población de interés y evitar asumir equivalencia métrica entre adaptaciones.

9. Validez, confiabilidad y límites de inferencia

Propiedad	Qué respalda la evidencia	Qué no permite concluir
Consistencia interna	Los ítems de los dominios superiores muestran covariación adecuada.	Que todas las funciones sean un único constructo o que α alto implique validez.
Estructura factorial	Existe apoyo reiterado para dos dominios generales.	Que cada adaptación reproduzca exactamente la misma asignación de funciones.
Estabilidad temporal	Las estimaciones conductuales y funcionales muestran estabilidad moderada a alta.	Que las funciones sean rasgos inmutables; pueden cambiar con contexto y tratamiento.
Validez clínica	Los perfiles son útiles para formular hipótesis y describir funciones.	Que una puntuación prediga por sí sola suicidio, gravedad médica o diagnóstico.

10. Consideraciones clínicas y éticas

10.1. Evaluación del riesgo

Advertencia esencial. La ISAS no sustituye una evaluación de ideación, intención, planificación, acceso a medios, intentos previos, factores protectores y riesgo inmediato. La autolesión no suicida y la conducta suicida son conceptualmente distintas, pero pueden coexistir.

- Explorar cada episodio reciente para diferenciar intención de regular malestar, ambivalencia e intención de morir.
- Valorar gravedad médica y necesidad de atención urgente.
- Preguntar de forma directa por ideación, plan, intención y conductas preparatorias.
- Activar el protocolo institucional cuando se identifique riesgo agudo o incapacidad para garantizar seguridad.
- Documentar la interpretación contextual, no solo las puntuaciones.

10.2. Uso con adolescentes

La escala se utiliza ampliamente con adolescentes, pero la administración debe considerar desarrollo, comprensión lingüística, consentimiento/asentimiento, límites de confidencialidad y participación de adultos responsables. El evaluador debe explicar antes de la aplicación qué información podría requerir comunicación para proteger la seguridad.

10.3. Sensibilidad del contenido

La enumeración de métodos de autolesión puede resultar activadora para algunas personas. La aplicación debe realizarse con una justificación clínica o investigativa clara, un entorno de contención y una estrategia posterior de revisión. No debe presentarse como material de autoevaluación sin soporte cuando existe vulnerabilidad conocida.

11. Fortalezas y limitaciones

Fortalezas	Limitaciones
Integra conductas y funciones en un único instrumento.	Se basa en autoinforme y memoria retrospectiva.
Evalúa 13 funciones con cobertura conceptual amplia.	No ofrece puntos de corte clínicos universales.
Permite un perfil funcional útil para la formulación.	Las funciones declaradas no equivalen necesariamente a contingencias observadas.

Fortalezas	Limitaciones
Cuenta con evidencia en muestras comunitarias y clínicas.	Algunas soluciones factoriales varían entre culturas y poblaciones.
Es breve en relación con la amplitud de información.	La frecuencia vital puede ser imprecisa en conductas repetitivas.
Dispone de versiones en español estudiadas empíricamente.	No sustituye entrevista clínica, evaluación médica ni evaluación del riesgo suicida.

13. Referencias bibliográficas

- Castro Silva, E., Benjet, C., Juárez García, F., Jurado Cárdenas, S., Lucio Gómez-Maqueo, M. E., & Valencia Cruz, A. (2016). Adaptación y propiedades psicométricas del Inventory of Statements About Self-Injury en estudiantes mexicanos. *Acta de Investigación Psicológica*, 6(3), 2544–2551. <https://doi.org/10.1016/j.aiprr.2016.08.004>
- Glenn, C. R., & Klonsky, E. D. (2011). One-year test–retest reliability of the Inventory of Statements About Self-Injury (ISAS). *Assessment*, 18(3), 375–378. <https://doi.org/10.1177/1073191111411669>
- Klonsky, E. D. (2007). The functions of deliberate self-injury: A review of the evidence. *Clinical Psychology Review*, 27(2), 226–239. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2006.08.002>
- Klonsky, E. D., & Glenn, C. R. (2009). Assessing the functions of non-suicidal self-injury: Psychometric properties of the Inventory of Statements About Self-Injury (ISAS). *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, 31(3), 215–219. <https://doi.org/10.1007/s10862-008-9107-z>
- Klonsky, E. D., Glenn, C. R., Styer, D. M., Olino, T. M., & Washburn, J. J. (2015). The functions of nonsuicidal self-injury: Converging evidence for a two-factor structure. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 9, Article 44. <https://doi.org/10.1186/s13034-015-0073-4>
- Nock, M. K., & Prinstein, M. J. (2004). A functional approach to the assessment of self-mutilative behavior. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 72(5), 885–890. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.72.5.885>
- Pérez, S., García-Alandete, J., Cañabate, M., & Marco, J. H. (2020). Confirmatory factor analysis of the Inventory of Statements About Self-Injury in a Spanish clinical sample. *Journal of Clinical Psychology*, 76(1), 102–117. <https://doi.org/10.1002/jclp.22844>